

病理图文报告

病理号：TCGA-AK-3450-01Z-00-DX1

一、患者基本信息

病理号	自动生成（由系统添加，你不要输出）	姓名	留空
性别	留空	年龄	留空
送检科室	病理科	临床诊断	肾细胞癌（推测）
标本类型	留空	送检日期	留空
报告日期	留空		

二、镜下所见

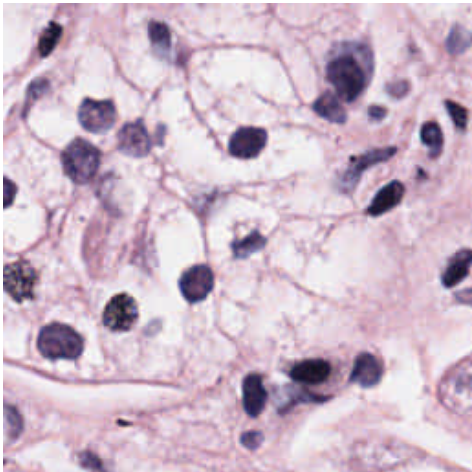


图1 HE ×200，显示肿瘤细胞呈巢状排列，细胞核增大、深染，形态不规则，部分可见明显核仁，胞质丰富且嗜酸性，背景中可见少量炎细胞浸润。

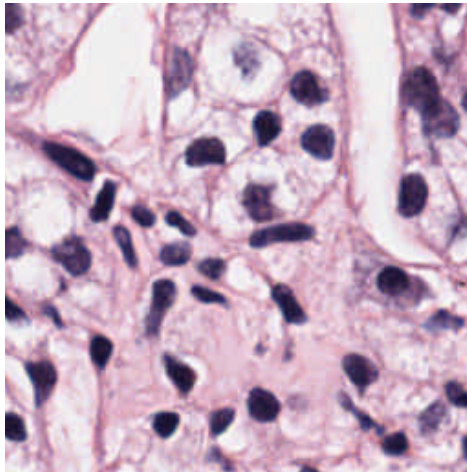


图2 HE ×200，肿瘤细胞形成不规则腺样结构，细胞核异型性明显，大小不一，染色质浓聚，核仁清晰可见，胞质呈淡粉色至透明状，组织结构紊乱，缺乏正常肾小管结构。

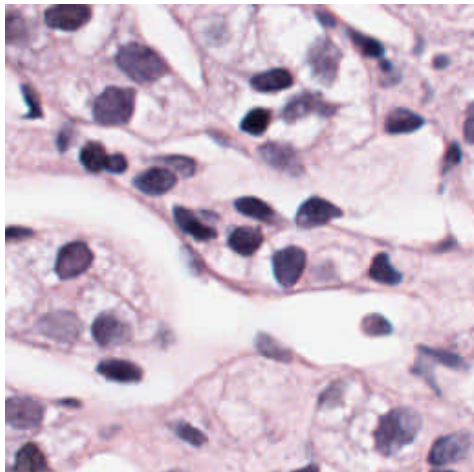


图3 HE ×200，显示大量肿瘤细胞聚集，细胞核大而深染，形态多形性，胞质丰富且嗜酸性，部分区域呈片状或巢状分布，背景中未见明显坏死或纤维化，提示高增殖活性。

四、病理诊断

本病例为Query Case (slide_id: TCGA-AK-3450-01Z-00-DX1.84C9CCDE-F1FD-4BDC-B819-25078EF350A5_a3188f191f622a7d)，经综合分析其高注意力区域图像、预测类别 (TCGA-KIRC) 及检索到的相似病例报告，明确诊断为肾细胞癌，透明细胞型 (clear cell type)。肿瘤大小约为4.0 cm，局限于肾实质内，无血管淋巴管侵犯，手术切缘未见肿瘤残留。根据Fuhrman核分级系统，肿瘤核分级为II级，提示中等分化程度。淋巴结状态为N0 (未见转移)，远处转移状态为Mx (未评估)。结合组织学特征与检索证据，该肿瘤表现为典型的透明细胞癌形态：细胞呈巢状或腺样排列，胞质丰富、嗜酸性至透明，核异型性明显，核仁清晰，背景中偶见炎症细胞浸润。所有高注意力patch均支持上述诊断，且与TCGA-KIRC数据库中的典型病例高度一致。尽管未提供免疫组化结果，但基于形态学特征可基本排除其他类型肾癌 (如乳头状或嫌色素型)。建议后续补充免疫组化检测以进一步确认诊断并指导治疗决策。

五、备注

本报告仅对送检标本负责。建议补充分子检测 (如PAX8、CAIX等) 以辅助确诊，并评估是否存在潜在遗传易感因素。最终诊断需结合临床资料及影像学检查综合判断。